NMOSD诊断与治疗

2025 · 正面

疑似：双眼＋核心症候

急性视力下降、脊髓症候或顽固呃逆/呕吐等须评估。查双眼矫正视力、视野、色觉、眼底；免疫治疗前尽量采血做AQP4-IgG CBA。

2025 p688–689、691–692

AQP4阳性诊断

≥1项核心临床特征＋可靠方法AQP4-IgG阳性＋排除其他诊断。仅脑脊液阳性不足确诊；AQP4/MOG双阳性须重复两项检测。

2025 p690、692–693

阴性/未知：条件更严格

≥2项不同核心特征，含视神经炎、急性LETM或极后区综合征之一；须空间多发、MRI附加条件及排除其他病因。完整标准见提取表。

2025 p692

阴性/未知：MRI附加条件

视神经炎：脑MRI正常/仅非特异白质病变，或视神经病灶>1/2长度/视交叉受累；脊髓病变或相应萎缩>3连续节段。完整附加条件见提取表。

2025 p692

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

NMOSD诊断与治疗

2025 · 背面

急性期：救治与升级

成人IVMP 1 g/d静滴×3–5 d后依原文递减；最初几天反应差或严重视神经炎，尽早血液净化。急性视神经炎不推荐IVIG。

2025 p694

尽早预防复发

AQP4阳性确诊即长期序贯；阴性第1次严重/第2次发作后考虑。萨特利珠120 mg皮下，第0、2、4周，后每4周；其他给药见提取表。

2025 p691、694、696–698

治疗安全与妊娠

相关单抗前筛HBV/结核；依库珠首剂前2周接种脑膜炎球菌疫苗。育龄避MMF；不要只因计划怀孕自行停药，稳定期计划并协作管理。

2025 p695–696、698

随访与用药禁忌

EDSS每3–6个月；MRI/AQP4每6–12个月。不推荐β-干扰素、那他珠、芬戈莫德、阿伦单抗、富马酸二甲酯用于AQP4阳性。

2025 p694、698

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转